CATEGORÍA: PROFESIONAL

EJE 1 · TRANSFORMACIONES DEL CUIDADO Y HUMANIZACIÓN

TEJER REDES, ACOMPAÑAR VIDAS: Una experiencia de participación comunitaria y cuidado de las personas mayores

María Cristina Vallejos[1]

[1] Centro de Salud San José de San Martín | Moreno – Norte, Argentina

1 INTRODUCCIÓN

La salud comunitaria integra atención sanitaria, vínculos sociales, participación y condiciones de vida. En Moreno–Norte, se reconocieron situaciones de soledad y dificultades para acceder a actividades recreativas entre algunas personas mayores. Ante ello, el Centro de Salud San José de San Martín impulsó un espacio de escucha, encuentro y acompañamiento. La propuesta es coherente con la Carta de Ottawa (OMS, 1986), centrada en la participación comunitaria, y con la Década del Envejecimiento Saludable 2021–2030 (OMS/OPS), que promueve entornos favorables para las personas mayores.

2 OBJETIVOS

Describir una experiencia comunitaria impulsada desde el centro de salud para reconocer situaciones de soledad y promover la participación de personas mayores. Se buscó facilitar encuentros significativos, fortalecer los vínculos entre vecinos y equipo de salud, recuperar saberes y experiencias de vida, y favorecer formas de cuidado colectivo en el barrio.

3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La propuesta se organizó en encuentros semanales en el centro de salud, concebidos como un espacio que excede la consulta médica. Se compartieron desayunos, charlas, caminatas barriales y actividades de intercambio de saberes. Se convocó a personas mayores del barrio y participaron familiares, vecinos, integrantes del equipo de salud e instituciones cercanas. La articulación con organizaciones barriales y referentes comunitarios permitió ampliar la convocatoria y construir relaciones de confianza. Las actividades priorizaron la escucha, la participación voluntaria y el reconocimiento de las experiencias de quienes asistieron. El relato recoge la práctica desarrollada y las apreciaciones de sus protagonistas; no presenta una evaluación cuantitativa del impacto.

DESAYUNOS COMPARTIDOS · **CAMINATAS BARRIALES** · **CHARLAS Y SABERES**

4 LOGROS Y APRENDIZAJES

NECESIDADES IDENTIFICADAS

- Soledad y falta de compañía.
- Dificultades para acceder a actividades recreativas y sociales.
- Necesidad de espacios de escucha y contención.
- Pocos vínculos con instituciones y vecinos.

RESULTADOS DESCRITOS

Durante los encuentros se fortalecieron los vínculos entre las personas mayores, el equipo de salud y la comunidad. Se consolidó un espacio de pertenencia en el que las personas participantes compartieron historias, inquietudes y conocimientos. También se amplió el contacto con instituciones y organizaciones barriales, lo que favoreció nuevas posibilidades de acompañamiento. Las caminatas y las actividades compartidas ofrecieron oportunidades de interacción y participación. Estos logros se describen cualitativamente a partir de la experiencia relatada; no constituyen mediciones de cambios clínicos ni permiten atribuir causalidad.

SECUENCIA DE LA PROPUESTA

01 **ENCUENTRO** — Desayunos compartidos

02 **MOVIMIENTO** — Caminatas en el barrio

03 **DIÁLOGO** — Charlas e intercambio

04 **REDES** — Participación comunitaria

5 CONCLUSIONES

Esta experiencia reafirma el valor del centro de salud como un lugar para encontrarse, escucharse y construir respuestas junto con la comunidad. La participación de las personas mayores y el intercambio entre actores del territorio fortalecen el tejido social y las redes de cuidado. Sostener encuentros periódicos, ampliar la articulación institucional y escuchar las necesidades emergentes son desafíos para dar continuidad a la propuesta. Dado el carácter descriptivo del relato, no corresponde afirmar efectos medidos sobre la salud ni generalizar sus resultados a otras comunidades.

«La salud también se construye en comunidad».

6 APORTE PARA ENFERMERÍA

La experiencia visibiliza la contribución de enfermería a la promoción de la salud más allá de la atención individual. Escuchar de manera activa, detectar necesidades sociales, orientar a las personas mayores y acompañar propuestas comunitarias forman parte de un cuidado integral, humano y situado. La articulación con familias, vecinos, instituciones y otros integrantes del equipo favorece un abordaje interdisciplinario. Como proyección, se propone registrar la participación, recuperar la voz de las personas mayores y evaluar la continuidad de los encuentros sin perder su carácter abierto y participativo.

7 REFERENCIAS

1. OMS (1986). Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud.
2. OMS (2020). Década del Envejecimiento Saludable (2021–2030): plan de acción.
3. OPS (s. f.). Década del Envejecimiento Saludable en las Américas: área de acción III (atención primaria).

OMS · OMS · OPS | Fuentes institucionales oficiales

CUIDAR TAMBIÉN ES ENCONTRARNOS

Relato de experiencia comunitaria | No se informan medidas de impacto ni datos personales.

APUBA

.UBA CIENCIAS MÉDICAS